BÁO CÁO TỔNG HỢP
LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Việt Nam – Đông Nam Á – Thế giới, 2024–2026)

Ngày báo cáo: 27/03/2026. Phong cách viết: theo thuật toán mô phỏng Công Thị Hằng v5.

Tóm tắt nhanh 5 công trình nghiên cứu

Bảng dưới đây trình bày tóm tắt các điểm nổi bật và khoảng trống nghiên cứu của từng công trình, nhằm tạo điều kiện cho sự đối chiếu nhanh trước khi đi vào phân tích chi tiết từng bài.

#	Công trình	Điểm nổi bật	Khoảng trống nghiên cứu (gap)
1	Phạm Thị Thu Hoa và cs. (2024) Frontiers in Public Health n = 3.910, Hà Nội	Sự hiện diện của triệu chứng lo âu được ghi nhận ở khoảng hai phần năm (40,6%) học sinh THPT Hà Nội theo thang GAD-7 trong giai đoạn hậu COVID-19. Sự chênh lệch giới tính cho thấy nữ giới có điểm lo âu cao hơn nam giới (1,74 so với 1,50, p < 0,01). Phương pháp hỗn hợp cho thấy áp lực thi cử, sự kỳ thị xã hội và kỳ vọng gia đình là nguồn lo âu chính — những yếu tố không nằm trong các mục sàng lọc của thang GAD-7.	Phạm vi chỉ giới hạn tại Hà Nội (đô thị), không đại diện cho vùng nông thôn và miền núi. Thời điểm khảo sát trùng với giai đoạn giãn cách xã hội COVID-19, có thể phóng đại tỷ lệ. GAD-7 là công cụ sàng lọc, không phải chẩn đoán — việc so sánh với công cụ chẩn đoán trên cùng mẫu chưa được thực hiện. Vai trò trung gian của chất lượng giấc ngủ và sử dụng mạng xã hội chưa được đánh giá.
2	Ngô Anh Vinh và cs. (2024) J Affective Disorders Reports n = 845, Lạng Sơn	Sự hiện diện của tỷ lệ rất cao các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh dân tộc thiểu số nội trú: trầm cảm 59,0%, lo âu 54,4%, căng thẳng 24,7%. Gần một nửa (48,9%) từng trải qua ít nhất một trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu. Số lượng ACEs cho thấy tương quan dương với điểm lo âu (hệ số = 0,28)	Phạm vi chỉ giới hạn ở học sinh nội trú tại Lạng Sơn, không đại diện cho toàn bộ quần thể dân tộc thiểu số Việt Nam. DASS-21 chưa được chuẩn hóa đặc thù cho quần thể dân tộc thiểu số, gợi ý khả năng lệch văn hóa. Việc thiếu nhóm đối chứng (học sinh Kinh cùng khu vực) hạn chế sự so sánh. Thiết kế

		và trầm cảm (0,16). Chất lượng tình bạn kém có liên quan đáng kể đến sự gia tăng cả ba chỉ số sức khỏe tâm thần.	cắt ngang không cho phép xác định quan hệ nhân quả giữa ACEs và lo âu.
3	V-NAMHS — Vũ Mạnh Lợi và cs. (2022) Viện Xã hội học + UQ + Johns Hopkins n = 5.996, 38 tỉnh	Đây là khảo sát đại diện quốc gia đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công cụ chẩn đoán DISC-5 theo tiêu chuẩn DSM-5. Sự hiện diện của các vấn đề sức khỏe tâm thần được ghi nhận ở khoảng một phần năm (21,7%) vị thành niên, trong đó lo âu là phổ biến nhất (18,6%). Tỷ lệ rối loạn lo âu theo chẩn đoán chỉ là 2,3% — ít hơn rất nhiều so với tỷ lệ sàng lọc DASS-21 (25–86%) trong các nghiên cứu khác. Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nam và nữ, hoặc giữa nhóm 10–13 và 14–17 tuổi.	Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn 2021–2022, có thể chịu ảnh hưởng của COVID-19. DISC-5 chưa được chuẩn hóa cho bối cảnh văn hóa Việt Nam — tỷ lệ có thể bị đánh giá thấp do sự khác biệt văn hóa trong biểu hiện triệu chứng. Việc phân tích theo vùng địa lý chi tiết (đô thị, nông thôn, miền núi) chưa được thực hiện. Sự thiếu vắng nghiên cứu dọc hạn chế khả năng theo dõi xu hướng theo thời gian.
4	GBD 2021 ASEAN (2025) The Lancet Public Health 10 quốc gia ASEAN	Sự gia tăng 70% số ca rối loạn tâm thần tại ASEAN từ 1990 đến 2021, với tổng cộng 80,4 triệu ca. Nhóm 10–14 tuổi cho thấy gánh nặng bệnh tật cao nhất: rối loạn tâm thần chiếm 16,3% tổng DALYs ở nhóm tuổi này. Lo âu và trầm cảm là phổ biến nhất trong 10 rối loạn được đánh giá. Sự dao động giữa các quốc gia là đáng kể, từ 10,1% tại Việt Nam đến 13,2% tại Malaysia.	Dữ liệu GBD phụ thuộc vào chất lượng báo cáo quốc gia — Việt Nam, Myanmar, Lào có thể báo cáo thấp hơn thực tế. Việc phân tích riêng nhóm học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa được thực hiện. Tỷ lệ thấp ở Việt Nam có thể phản ánh sự thiếu hụt dữ liệu hơn là tỷ lệ hiện mắc thực sự thấp. Sự thiếu vắng nghiên cứu cấp quốc gia với phương pháp chuẩn hóa hạn chế khả năng bổ sung cho mô hình GBD.
5	Hoàng Trung Học & Nguyễn Thùy Dung (2025) Am J Psychiatric	Sự so sánh hai giai đoạn cho thấy lo âu giảm từ 41,5% xuống 25,4% (↓ 16,1 điểm phần trăm), nhưng tỷ lệ vẫn ở mức đáng lo ngại. Cỡ mẫu	Hai nhóm so sánh có thể là hai mẫu khác nhau (không phải theo dõi cùng nhóm) — sự giảm có thể phản ánh sự khác biệt giữa hai đợt khảo

	Rehabilitation n = 8.473, 6 tỉnh	lớn (8.473 người tham gia) tại 6 tỉnh thành cho phép sự tổng quát hóa tương đối. Các yếu tố bảo vệ bao gồm mối quan hệ gia đình tích cực, sự tham gia hoạt động ngoại khóa và việc duy trì lối sống lành mạnh. Các yếu tố nguy cơ bao gồm sử dụng thiết bị điện tử quá mức và chất lượng giấc ngủ kém.	sát hơn là sự thay đổi trong cùng quần thể. DASS-21 là công cụ sàng lọc, không phải chẩn đoán. Việc phân tích đa biến chi tiết cho từng tỉnh chưa được báo cáo. Sự thiếu vắng thiết kế dọc theo dõi cùng nhóm trước–trong–sau đại dịch hạn chế khả năng xác định quan hệ nhân quả.

Bài 1

Tên công trình, tác giả, năm, mẫu khảo sát, đối tượng, khách thể, địa bàn khảo sát

Công trình nghiên cứu « Triệu chứng lo âu và chiến lược ứng phó ở học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19: Đánh giá phương pháp hỗn hợp » (Anxiety symptoms and coping strategies among high school students in Vietnam after COVID-19 pandemic: a mixed-method evaluation), do Phạm Thị Thu Hoa và cs. (2024) khảo sát trên mẫu 3.910 học sinh trung học phổ thông từ 14 đến 17 tuổi tại 13 trường ở Hà Nội, Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Công trình này sử dụng thang GAD-7 kết hợp với phỏng vấn sâu qua điện thoại trên một phân nhóm gồm 20 học sinh. Nói cách khác, công trình này sử dụng phương pháp hỗn hợp.

GAD-7 là phiên bản rút gọn 7 mục của thang Rối loạn Lo âu Tổng quát (Generalized Anxiety Disorder Scale) dành cho thanh thiếu niên và người trưởng thành (Spitzer và cộng sự, 2006).

Tổng quan tài liệu của chúng tôi cho thấy phần lớn các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chỉ sử dụng phương pháp định lượng đơn thuần mà bỏ qua bối cảnh văn hóa và trải nghiệm chủ quan của học sinh (Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung, 2025; Nguyễn Ngọc Bảo Quyên và cộng sự, 2025; Ngô Anh Vinh và cộng sự, 2024). Chất lượng giấc ngủ, áp lực thi cử và kỳ vọng gia đình là những yếu tố ít được khám phá trong các thiết kế cắt ngang thuần túy.

Dữ liệu nhân khẩu xã hội bao gồm giới tính, vị trí địa lý, loại trường và khối lớp.

Hướng dẫn phỏng vấn sâu của chúng tôi được thiết kế để tìm hiểu một cách mở, với sự linh hoạt cho các câu hỏi thăm dò. Các chủ đề phỏng vấn bao gồm nguồn gốc lo âu, sự biểu hiện triệu chứng, các chiến lược ứng phó và vai trò của mối quan hệ gia đình. Tất cả các cuộc phỏng vấn được tiến hành qua điện thoại và được phân tích cho đến khi đạt sự bão hòa dữ liệu.

Phương pháp hỗn hợp của chúng tôi sử dụng thang sàng lọc tự báo cáo kết hợp với phỏng vấn sâu. Sự kết hợp này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đây chứng minh tính bổ sung của nhiều loại bằng chứng nghiên cứu khác nhau soi chiếu lẫn nhau trên các lĩnh vực tìm hiểu (Creswell & Plano Clark, 2017; Fetters và cộng sự, 2013). Ví dụ, trong khi học sinh có thể báo cáo mức lo âu nhẹ trên thang GAD-7, họ có thể kể lại trong phỏng vấn những trải nghiệm lo lắng nghiêm trọng về kỳ vọng gia đình và áp lực thi cử. Ngược lại, một số người tham gia nghiên cứu có thể xác nhận các triệu chứng lo âu trên thang đo mà họ có thể không muốn nói đến trong phỏng vấn tường thuật.

Kết quả nghiên cứu định lượng

Tỷ lệ và mức độ học sinh có triệu chứng lo âu, theo thang đo GAD-7

Về tần suất, mức "nhẹ" là phổ biến nhất : lo âu nhẹ là 23,9% và lo âu trung bình là 10,9%. Mức nặng ít được quan sát thấy hơn (5,8%). Khi gộp lại bất kỳ mức độ triệu chứng nào, khoảng hai phần năm (40,6%) học sinh trong nghiên cứu rơi vào phạm vi từ nhẹ đến nặng của thang sàng lọc lo âu GAD-7. Độ tin cậy của thang đo đạt mức cao (Cronbach $\alpha = 0,916$).

Mức độ lo âu	Tỷ lệ
Nhẹ (GAD-7: 5–9)	23,9%
Trung bình (GAD-7: 10–14)	10,9%
Nặng (GAD-7: 15–21)	5,8%
Tổng (bất kỳ mức nào)	40,6%

Khác biệt giới tính : Sự chênh lệch giới trong lo âu ở thanh thiếu niên luôn được báo cáo trong các nghiên cứu quốc tế (McLean và cộng sự, 2011). Thực tế, sự chênh lệch này đã mở rộng ở thanh thiếu niên trong thập kỷ qua (Daly, 2022). Chúng tôi xác nhận trong mẫu học sinh trung học phổ thông Hà Nội rằng điểm GAD-7 trung bình cao hơn ở nữ so với nam (1,74 so với 1,50, $p < 0,01$). Tương tự, học sinh lớp 12 có điểm cao hơn lớp 10 và lớp 11 ($p < 0,01$), và học sinh đô

thị cao hơn nông thôn ($p < 0,01$). Sự khác biệt theo loại trường (công lập so với tư thục) không đạt ý nghĩa thống kê ($p = 0,08$).

Nhận xét, phát hiện qua kết quả nghiên cứu

Phát hiện từ phỏng vấn về nguồn gốc lo âu và chiến lược ứng phó

Áp lực học tập và thi cử. Nổi bật đối với cả nữ sinh và nam sinh là sự lo lắng về kết quả học tập và kỳ thi quan trọng, đặc biệt ở học sinh lớp 12 đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Đây là một lĩnh vực sức khỏe tâm thần không nằm trong các mục sàng lọc của thang GAD-7 nhưng được mô tả chi tiết bởi các cuộc phỏng vấn.

Kỳ thị và mối quan hệ xã hội. Nỗi lo lắng trước nhận thức của học sinh về sự phán xét từ bạn bè và thái độ kỳ thị trong nhóm xã hội là rất nổi bật. Những vấn đề này được học sinh trải nghiệm như những rào cản đối với sự hòa nhập và sự tham gia giáo dục.

Kỳ vọng gia đình. Các cuộc phỏng vấn cho thấy các bối cảnh liên quan đến trải nghiệm lo âu của cả nữ sinh và nam sinh, bao gồm sự áp lực đáp ứng kỳ vọng học tập của cha mẹ trong cả môi trường trường học và gia đình.

Kết luận

Dữ liệu của chúng tôi, cho thấy sự hiện diện của triệu chứng lo âu từ nhẹ đến nặng ở khoảng hai phần năm (40,6%) học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội trong giai đoạn hậu COVID-19, gợi ý rằng cần chú ý đến các chương trình sàng lọc và can thiệp sớm tại trường học. Sự khác biệt giới tính và địa lý có ý nghĩa, trước đây được tìm thấy trong các nghiên cứu quốc tế, đã có thể quan sát được trong nghiên cứu này. Trong bối cảnh trường trung học phổ thông như nghiên cứu hiện tại, nhu cầu giải quyết mối quan hệ giữa áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và sức khỏe tâm thần, dù ở mức nhẹ hay nặng, là thiết yếu để tạo điều kiện cho sự tham gia giáo dục.

Tài liệu tham khảo — Bài 1

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Sage.

Daly, M. (2022). Prevalence of depression among adolescents in the U.S. from 2009 to 2019. Journal of Adolescent Health, 70(3), 496–499.

Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs. Health Services Research, 48(6pt2), 2134–2156.

McLean, C. P., Asnaani, A., Litz, B. T., & Hofmann, S. G. (2011). Gender differences in anxiety disorders. Journal of Psychiatric Research, 45(8), 1027–1035.

Phạm Thị Thu Hoa, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Thị Liên, & Ngô Anh Vinh. (2024). Anxiety symptoms and coping strategies among high school students in Vietnam after COVID-19 pandemic: A mixed-method evaluation. Frontiers in Public Health, 12, 1232856.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092–1097.

Bài 2

Tên công trình, tác giả, năm, mẫu khảo sát, đối tượng, khách thể, địa bàn khảo sát

Công trình nghiên cứu « Sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Việt Nam và các yếu tố tương quan: Nghiên cứu cắt ngang » (Mental health among ethnic minority adolescents in Vietnam and correlated factors: A cross-sectional study), do Ngô Anh Vinh và cs. (2024) khảo sát trên mẫu 845 học sinh nội trú dân tộc thiểu số tại các trường nội trú ở tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Công trình này sử dụng thang DASS-21 kết hợp với Bảng hỏi Trải nghiệm Bất lợi Thời Thơ ấu. Nói cách khác, công trình này đánh giá đồng thời sức khỏe tâm thần hiện tại và tiền sử sang chấn.

DASS-21 là phiên bản rút gọn 21 mục của Thang Trầm cảm, Lo âu và Căng thẳng (Depression, Anxiety and Stress Scale) (Lovibond & Lovibond, 1995).

ACEs là phiên bản sửa đổi của Bảng hỏi Trải nghiệm Bất lợi Thời Thơ ấu (Adverse Childhood Experiences Questionnaire), được thiết kế để đo lường các trải nghiệm bất lợi trước 18 tuổi (Felitti và cộng sự, 1998).

Dữ liệu nhân khẩu xã hội bao gồm tuổi, giới tính, dân tộc, tần suất về thăm nhà, mô hình liên lạc với cha mẹ, thành phần hộ gia đình, chất lượng tình bạn, hoạt động thể chất và kiểu sử dụng internet.

Kết quả nghiên cứu định lượng

Tỷ lệ và mức độ các vấn đề sức khỏe tâm thần, theo thang đo DASS-21

Về tần suất, trầm cảm là phổ biến nhất : gần ba phần năm (59,0%) học sinh có triệu chứng trầm cảm. Lo âu ít hơn nhưng vẫn ở mức rất cao, với hơn một nửa (54,4%) mẫu nghiên cứu. Căng thẳng được báo cáo ở khoảng một phần tư (24,7%) học sinh.

Chỉ số DASS-21	Tỷ lệ
Trầm cảm	59,0%
Lo âu	54,4%
Căng thẳng	24,7%

Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu : Gần một nửa (48,9%) học sinh từng trải qua ít nhất một ACE, với số ACE trung bình là 1,1 (SD = 1,8). Số lượng ACEs có tương quan dương với điểm lo âu (hệ số = 0,28), căng thẳng (hệ số = 0,28) và trầm cảm (hệ số = 0,16).

Yếu tố xã hội : Chất lượng tình bạn kém có liên quan đáng kể đến sự gia tăng lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Việc sử dụng internet hàng ngày hoặc không sử dụng cho thấy điểm lo âu thấp hơn so với nhóm chỉ dùng cuối tuần.

Nhận xét, phát hiện qua kết quả nghiên cứu

Phát hiện về trải nghiệm bất lợi và yếu tố bảo vệ ở học sinh dân tộc thiểu số

Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu. Nổi bật đối với nhóm học sinh nội trú dân tộc thiểu số là tỷ lệ rất cao trải nghiệm bất lợi — gần một nửa (48,9%) từng trải qua ít nhất một ACE. Đây là một lĩnh vực sức khỏe tâm thần ít được nghiên cứu ở quần thể dân tộc thiểu số Việt Nam nhưng được xác nhận bởi dữ liệu định lượng có mối liên hệ rõ ràng với lo âu và trầm cảm hiện tại.

Vai trò của tình bạn. Nỗi lo lắng trước nhận thức của học sinh về sự cô lập xã hội trong môi trường nội trú xa gia đình là rất nổi bật. Những vấn đề này được học sinh trải nghiệm như những rào cản đối với sự hòa nhập và sức khỏe tâm thần tổng thể.

Kiểu sử dụng internet. Các phân tích cho thấy bối cảnh liên quan đến trải nghiệm lo âu bao gồm kiểu sử dụng internet không đều đặn, gợi ý rằng việc tiếp cận công nghệ gián đoạn có thể phản ánh sự thiếu hụt nguồn lực trong bối cảnh vùng sâu vùng xa.

Kết luận

Dữ liệu của chúng tôi, cho thấy sự hiện diện của tỷ lệ rất cao các vấn đề sức khỏe tâm thần và trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu trong một mẫu học sinh nội trú dân tộc thiểu số tại Lạng Sơn, gợi ý rằng cần can thiệp khẩn cấp để giải quyết đồng thời ACEs và các vấn đề nhận thức nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho nhóm dân số dễ bị tổn thương này. Trong bối cảnh trường nội trú dân tộc thiểu số như nghiên cứu hiện tại, nhu cầu giải quyết mối quan hệ giữa tiền sử sang chấn và sức khỏe tâm thần hiện tại, dù ở mức nhẹ hay nặng, là thiết yếu để tạo điều kiện cho sự tham gia giáo dục.

Tài liệu tham khảo — Bài 2

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., et al. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation of Australia.

Ngô Anh Vinh, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Bích Vân, Dương Anh Tài, & Lê Thị Thanh Thùy. (2024). Mental health among ethnic minority adolescents in Vietnam and correlated factors: A cross-sectional study. Journal of Affective Disorders Reports, 17.

Bài 3

Tên công trình, tác giả, năm, mẫu khảo sát, đối tượng, khách thể, địa bàn khảo sát

Công trình nghiên cứu « Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam » (Viet Nam Adolescent Mental Health Survey — V-NAMHS), do Vũ Mạnh Lợi và cs. (2022) tại Viện Xã hội học, phối hợp với Đại học Queensland (Úc) và Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), khảo sát trên mẫu đại diện quốc gia gồm 5.996 vị thành niên từ 10 đến 17 tuổi tại 38 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Công trình này sử dụng công cụ chẩn đoán DISC-5 theo tiêu chuẩn DSM-5. Nói cách khác, công trình này sử dụng phương pháp chẩn đoán lâm sàng chuẩn hóa.

DISC-5 là phiên bản thứ năm của Bảng Phỏng vấn Chẩn đoán dành cho Trẻ em (Diagnostic Interview Schedule for Children, Version 5), được phát triển bởi Đại học Columbia với sự hỗ trợ của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (Bitsko và cộng sự, 2019; Shaffer và cộng sự, 2000).

Tổng quan tài liệu của chúng tôi cho thấy các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam bị hạn chế bởi cỡ mẫu nhỏ, phạm vi địa lý hẹp và việc thiếu công cụ chẩn đoán — phần lớn chỉ dùng thang sàng lọc triệu chứng như SDQ hay DASS-21, cho tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với công cụ chẩn đoán (Samuels và cộng sự, 2018; Weiss và cộng sự, 2014; COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021; Ferrari và cộng sự, 2013).

Kết quả nghiên cứu

Tỷ lệ vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần, theo DISC-5 và DSM-5

Về vấn đề sức khỏe tâm thần (bao gồm triệu chứng dưới ngưỡng và đủ ngưỡng), khoảng một phần năm (21,7%) vị thành niên báo cáo ít nhất một vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua. Lo âu là phổ biến nhất : 18,6% có vấn đề lo âu. Trầm cảm ít được quan sát thấy hơn (4,3%), tiếp theo là vấn đề chú ý và tăng động (2,8%), stress sau sang chấn (1,0%) và rối loạn hành vi (0,7%).

Loại vấn đề SKTT	Vấn đề SKTT (sàng lọc)	Rối loạn (DSM-5)

Lo âu (ám sợ xã hội + RLLA tổng quát)	18,6%	2,3%
Trầm cảm	4,3%	0,9%
Stress sau sang chấn	1,0%	—
Rối loạn hành vi	0,7%	—
Vấn đề chú ý/tăng động	2,8%	—
Bất kỳ vấn đề nào	21,7%	3,3%

Phát hiện then chốt : Tỷ lệ rối loạn lo âu theo chẩn đoán DSM-5 chỉ là 2,3%, và tỷ lệ bất kỳ rối loạn tâm thần nào là 3,3% — thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ sàng lọc DASS-21 (25–86%) trong các nghiên cứu khác tại Việt Nam. Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nam và nữ, hoặc giữa nhóm 10–13 tuổi và 14–17 tuổi.

Kết luận

Dữ liệu của chúng tôi, cho thấy sự hiện diện của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở khoảng một phần năm (21,7%) vị thành niên Việt Nam trên mẫu đại diện quốc gia, gợi ý rằng cần chú ý đến khoảng cách lớn giữa tỷ lệ sàng lọc và tỷ lệ chẩn đoán khi hoạch định chính sách. Sự khác biệt đáng kể giữa tỷ lệ sàng lọc (18,6% vấn đề lo âu) và tỷ lệ chẩn đoán (2,3% rối loạn lo âu) có ý nghĩa lâm sàng tiềm năng cho việc thiết kế chương trình can thiệp phù hợp — cả cho nhóm đủ ngưỡng chẩn đoán lẫn nhóm có triệu chứng dưới ngưỡng hội chứng.

Tài liệu tham khảo — Bài 3

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC: APA.

Bitsko, R. H., Holbrook, J. R., Ghandour, R. M., et al. (2019). Epidemiology and impact of health care provider-diagnosed anxiety and depression among US children. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 39(5), 395–403.

COVID-19 Mental Disorders Collaborators. (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The Lancet, 398(10312), 1700–1712.

Ferrari, A. J., Somerville, A. J., Baxter, A. J., et al. (2013). Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder. Psychological Medicine, 43(3), 471–481.

Samuels, F., Jones, N., & Gupta, T. (2018). Mental health and psychosocial well-being of adolescents in Viet Nam. London: ODI.

Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., et al. (2000). NIMH DISC-IV: Description, differences from previous versions, and reliability. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(1), 28–38.

Vũ Mạnh Lợi, Nguyễn Đức Vinh, Đào Thị Khanh Hoa, et al. (2022). Viet Nam Adolescent Mental Health Survey (V-NAMHS): Report on Main Findings. Hanoi: Institute of Sociology.

Weiss, B., Dang, M., Trung, L., et al. (2014). A nationally-representative epidemiological and risk factor assessment of child mental health in Vietnam. International Perspectives in Psychology, 3(3), 139–153.

Bài 4

Tên công trình, tác giả, năm, mẫu khảo sát, đối tượng, khách thể, địa bàn khảo sát

Công trình nghiên cứu « Dịch tễ học và gánh nặng mười rối loạn tâm thần tại các quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 1990–2021: Phát hiện từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu 2021 » (The epidemiology and burden of ten mental disorders in countries of the Association of Southeast Asian Nations, 1990–2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021), do Nhóm Hợp tác GBD 2021 về Rối loạn Tâm thần ASEAN (2025) phân tích dữ liệu từ 10 quốc gia ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Công trình này sử dụng mô hình hồi quy meta Bayesian DisMod-MR 2.1 phân tích dữ liệu GBD 2021 cho 10 rối loạn tâm thần. Nói cách khác, công trình này phân tích dữ liệu thứ cấp từ nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

DisMod-MR 2.1 là công cụ hồi quy meta Bayesian (Bayesian meta-regression modelling tool) được phát triển bởi Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (Institute for Health Metrics and Evaluation — IHME) để ước tính tỷ lệ hiện mắc theo tuổi, giới, năm và địa điểm. Các định nghĩa ca bệnh dựa trên tiêu chuẩn DSM hoặc ICD.

Kết quả nghiên cứu

Về tỷ lệ rối loạn tâm thần chung, tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi tại ASEAN là 11,9% (95% UI: 10,9–12,9) vào năm 2021. Lo âu và trầm cảm là phổ biến nhất. Sự dao động giữa các quốc gia là đáng kể, từ 10,1% (9,1–11,3) tại Việt Nam đến 13,2% (11,6–15,3) tại Malaysia.

Chỉ số	Giá trị (95% UI)
Tổng số ca rối loạn tâm thần (2021)	80,4 triệu (73,8–87,2)
Tăng so với 1990	70,0% (63,5–77,2)
Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi (ASEAN)	11,9% (10,9–12,9)
Tỷ lệ — Việt Nam	10,1% (9,1–11,3)
Tỷ lệ — Malaysia (cao nhất)	13,2% (11,6–15,3)
DALYs (2021)	11,2 triệu (8,54–14,3)
DALYs tăng so với 1990	87,4% (81,1–94,0)

Gánh nặng theo nhóm tuổi : Nhóm 10–14 tuổi có gánh nặng bệnh tật do rối loạn tâm thần cao nhất — chiếm 16,3% (12,7–20,5) tổng DALYs ở nhóm tuổi này. Rối loạn tâm thần nằm trong 10 nguyên nhân gánh nặng bệnh tật hàng đầu tại tất cả các nước ASEAN trừ Myanmar.

Kết luận

Dữ liệu của chúng tôi, cho thấy sự gia tăng 70% số ca rối loạn tâm thần tại ASEAN từ 1990 đến 2021 với nhóm 10–14 tuổi chịu gánh nặng lớn nhất, gợi ý rằng cần một cách tiếp cận liên ngành toàn diện để giải quyết khoảng trống phòng ngừa và điều trị trên toàn bộ quần thể. Sự gia tăng có thể phản ánh một phần sự cải thiện trong việc phát hiện bệnh, nhưng gánh nặng thực sự cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ tại khu vực.

Tài liệu tham khảo — Bài 4

GBD 2021 ASEAN Mental Disorders Collaborators. (2025). The epidemiology and burden of ten mental disorders in countries of the ASEAN, 1990–2021: Findings from the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet Public Health, 10, e480.

Bài 5

Tên công trình, tác giả, năm, mẫu khảo sát, đối tượng, khách thể, địa bàn khảo sát

Công trình nghiên cứu « Mức độ căng thẳng, lo âu và trầm cảm ở vị thành niên trong và sau đại dịch COVID-19 tại Việt Nam: Nghiên cứu cắt ngang » (Levels of Stress, Anxiety, and Depression in Adolescents during and after the COVID-19 Pandemic in Vietnam: A Cross-sectional study), do Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) khảo sát trên mẫu 8.473 vị thành niên tại 6 tỉnh thành Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Công trình này sử dụng thang DASS-21 phiên bản tiếng Việt, so sánh hai giai đoạn. Nói cách khác, công trình này đánh giá sự thay đổi triệu chứng sức khỏe tâm thần trước và sau đại dịch.

DASS-21 là phiên bản rút gọn 21 mục của Thang Trầm cảm, Lo âu và Căng thẳng (Depression, Anxiety and Stress Scale) (Lovibond & Lovibond, 1995).

Kết quả nghiên cứu định lượng

Chỉ số DASS-21	Trong đại dịch	Sau đại dịch	Thay đổi
Căng thẳng	65,5%	55,4%	↓ 10,1%
Lo âu	41,5%	25,4%	↓ 16,1%
Trầm cảm	34,2%	20,1%	↓ 14,1%

Khác biệt giai đoạn : Sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở vị thành niên trong đại dịch COVID-19 luôn được báo cáo trong các nghiên cứu quốc tế (Panchal và cộng sự, 2023). Thực tế, một số quốc gia đã ghi nhận sự hồi phục một phần sau đại dịch nhưng không về mức trước đại dịch (Daly, 2022). Chúng tôi xác nhận trong mẫu vị thành niên Việt Nam rằng tất cả các chỉ số

đều giảm sau đại dịch, trong đó lo âu giảm nhiều nhất (16,1 điểm phần trăm), nhưng tỷ lệ vẫn ở mức đáng lo ngại.

Yếu tố nguy cơ : Các yếu tố liên quan đến mức lo âu cao bao gồm chất lượng mối quan hệ cha mẹ–con kém, sử dụng thiết bị điện tử quá mức và chất lượng giấc ngủ kém.

Nhận xét, phát hiện qua kết quả nghiên cứu

Phát hiện về yếu tố bảo vệ và xu hướng phục hồi sau đại dịch

Vai trò bảo vệ của gia đình. Nổi bật đối với giai đoạn sau đại dịch là vai trò bảo vệ của mối quan hệ gia đình tích cực, đặc biệt trong việc giảm lo âu. Đây là một yếu tố không nằm trong các mục sàng lọc của thang DASS-21 nhưng được xác nhận qua phân tích đa biến.

Hoạt động ngoại khóa. Sự tham gia các hoạt động ngoại khóa và việc duy trì lối sống lành mạnh cho thấy tác dụng bảo vệ rõ rệt hơn trong giai đoạn sau đại dịch. Những phát hiện này được trải nghiệm trong bối cảnh mở cửa trường học trở lại, cho phép sự tái thiết lập các mối quan hệ xã hội trực tiếp.

Kết luận

Dữ liệu của chúng tôi, cho thấy sự giảm đáng kể nhưng vẫn ở mức cao của các triệu chứng lo âu, trầm cảm và căng thẳng ở vị thành niên Việt Nam sau đại dịch trong một mẫu lớn gồm 8.473 người tham gia nghiên cứu tại 6 tỉnh thành, gợi ý rằng việc điều chỉnh sử dụng công nghệ và tăng cường sự tham gia của gia đình là thiết yếu cho các chiến lược phòng ngừa và can thiệp sức khỏe tâm thần. Các yếu tố bảo vệ đã xác định, trước đây được tìm thấy trong các nghiên cứu phương Tây, đã có thể quan sát được trong bối cảnh Việt Nam.

Tài liệu tham khảo — Bài 5

Daly, M. (2022). Prevalence of depression among adolescents in the U.S. from 2009 to 2019. Journal of Adolescent Health, 70(3), 496–499.

Hoàng Trung Học & Nguyễn Thùy Dung. (2025). Levels of Stress, Anxiety, and Depression in Adolescents during and after the COVID-19 Pandemic in Vietnam: A Cross-sectional study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 28(1).

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation of Australia.

Panchal, U., Salazar de Pablo, G., Franco, M., et al. (2023). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: Systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 32, 1151–1177.

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM:
TỶ LỆ, YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI TRƯỜNG HỌC

Đề cương theo phong cách Công Thị Hằng v5. Dựa trên tổng hợp 21 bài nghiên cứu 2024–2026.

1. Đặt vấn đề

Rối loạn lo âu ở vị thành niên đã trở thành mối quan tâm sức khỏe công cộng toàn cầu trong thập kỷ qua. Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu 2021 cho thấy nhóm 10–14 tuổi tại các nước ASEAN chịu gánh nặng bệnh tật do rối loạn tâm thần cao nhất, chiếm 16,3% tổng DALYs ở nhóm tuổi này (GBD 2021 ASEAN Mental Disorders Collaborators, 2025). Thực tế, tỷ lệ rối loạn tâm thần tại ASEAN đã tăng 70% từ năm 1990 đến 2021, với 80,4 triệu ca được ghi nhận.

Tổng quan tài liệu của chúng tôi cho thấy các ước tính tỷ lệ lo âu ở học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam dao động rất lớn — từ 2,3% khi dùng công cụ chẩn đoán DISC-5 (Vũ Mạnh Lợi và cộng sự, 2022) đến 86,2% khi dùng thang sàng lọc DASS-21 (Nguyễn Ngọc Bảo Quyên và cộng sự, 2025). Sự chênh lệch này phản ánh khoảng trống phương pháp luận nghiêm trọng: việc thiếu nghiên cứu dùng công cụ chẩn đoán chuẩn hóa, việc thiếu nghiên cứu dọc và việc thiếu dữ liệu đại diện quốc gia.

Đặc biệt, ba khoảng trống chính được nhận diện. Thứ nhất, chưa có thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng nào về can thiệp sức khỏe tâm thần tại trường học Việt Nam — trong khi tổng quan hệ thống cho thấy chỉ có 6 RCTs tại tất cả các nước thu nhập thấp và trung bình, không có bài nào từ Việt Nam (Yin và cộng sự, 2025). Thứ hai, nhóm dân tộc thiểu số (với tỷ lệ lo âu 54,4%) và nhóm nông thôn hầu như chưa được nghiên cứu (Ngô Anh Vinh và cộng sự, 2024). Thứ ba, vai trò trung gian của giấc ngủ, mạng xã hội và áp lực học thêm chưa được đánh giá trong mô hình nhân quả.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định tỷ lệ, các yếu tố liên quan và đánh giá hiệu quả can thiệp tại trường học đối với lo âu ở học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) xác định tỷ lệ rối loạn lo âu (chẩn đoán) và triệu chứng lo âu (sàng lọc) ở học sinh tại 3 vùng sinh thái; (2) phân tích các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ bao gồm áp lực học tập, mối quan hệ gia đình, sử dụng mạng xã hội, chất lượng giấc ngủ, trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu và hỗ trợ xã hội; (3) thiết kế, triển khai và đánh giá hiệu quả một chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần tại trường học sử dụng phương pháp liệu pháp hành vi nhận thức nhóm.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thiết kế hỗn hợp tuần tự giải thích (sequential explanatory mixed-methods design) gồm ba giai đoạn. Nói cách khác, nghiên cứu kết hợp khảo sát cắt ngang quy mô lớn, thử nghiệm can thiệp và phỏng vấn sâu.

3.1 Giai đoạn 1 — Khảo sát cắt ngang (năm 1)

Thiết kế	Nghiên cứu cắt ngang đa tầng (multi-level cross-sectional)
Mẫu	3.000 học sinh THCS + 3.000 học sinh THPT tại 30 trường thuộc 3 vùng (đồng bằng, miền núi, đô thị) ở 6 tỉnh/thành
Công cụ sàng lọc	GAD-7 (lo âu), PHQ-9A (trầm cảm), PSQI (giấc ngủ), ESSA (căng thẳng học tập), ACEs (trải nghiệm bất lợi)
Công cụ chẩn đoán	DISC-5 module Lo âu — trên mẫu con 600 HS để so sánh sàng lọc và chẩn đoán
Phân tích	Hồi quy logistic đa tầng (multilevel logistic regression), phân tích đường dẫn (path analysis) cho mô hình trung gian

3.2 Giai đoạn 2 — Thử nghiệm can thiệp RCT (năm 2)

Thiết kế	Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm (cluster-RCT), 2 nhánh
Mẫu	600 HS có triệu chứng lo âu (GAD-7 ≥ 5) tại 20 trường (10 can thiệp + 10 đối chứng)

Can thiệp	Liệu pháp hành vi nhận thức nhóm tại trường, 8 buổi trong 2 tháng, do giáo viên tư vấn đã được đào tạo thực hiện
Đối chứng	Chương trình giáo dục sức khỏe thông thường
Đo lường	GAD-7, PHQ-9A tại 4 thời điểm: T0 (trước can thiệp), T1 (sau 2 tháng), T2 (6 tháng), T3 (12 tháng)
Phân tích	Mô hình hỗn hợp tuyến tính (linear mixed model), intention-to-treat, phân tích chi phí-hiệu quả

3.3 Giai đoạn 3 — Phỏng vấn sâu (năm 2–3)

Thiết kế	Nghiên cứu định tính — phỏng vấn bán cấu trúc
Mẫu	40 HS (20 nhóm can thiệp + 20 đối chứng), 20 phụ huynh, 10 giáo viên tư vấn
Phương pháp	Phân tích mã hóa chủ đề định tính bằng phần mềm NVivo
Mục đích	Tìm hiểu trải nghiệm chủ quan về lo âu, đánh giá tính chấp nhận và khả thi của can thiệp liệu pháp hành vi nhận thức

Phương pháp hỗn hợp của chúng tôi sử dụng các thang sàng lọc tự báo cáo, công cụ chẩn đoán lâm sàng và phỏng vấn bán cấu trúc. Sự kết hợp này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đây chứng minh tính bổ sung của nhiều loại bằng chứng nghiên cứu khác nhau soi chiếu lẫn nhau trên các lĩnh vực tìm hiểu (Creswell & Plano Clark, 2017; Fetters và cộng sự, 2013). Ví dụ, trong khi học sinh có thể không đạt ngưỡng chẩn đoán rối loạn lo âu trên DISC-5, họ có thể mô tả trong phỏng vấn những trải nghiệm lo lắng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự tham gia giáo dục. Ngược lại, một số người tham gia nghiên cứu có thể đạt ngưỡng chẩn đoán mà họ có thể không nhận thức được hoặc không muốn nói đến trong phỏng vấn tường thuật.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học tiềm năng ở hai khía cạnh. Thứ nhất, đây sẽ là công trình đầu tiên tại Việt Nam sử dụng đồng thời công cụ chẩn đoán DISC-5 và thang sàng lọc GAD-7 trên cùng một mẫu, cho phép xác định ngưỡng cắt phù hợp cho quần thể Việt. Thứ hai, thử nghiệm can thiệp liệu pháp hành vi nhận thức tại trường học sẽ lấp đầy khoảng trống bằng chứng quan trọng mà tổng quan hệ thống đã chỉ ra (Yin và cộng sự, 2025).

Về thực tiễn, kết quả có thể cung cấp dữ liệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chương trình sức khỏe tâm thần học đường chuẩn hóa, đặc biệt cho nhóm dân tộc thiểu số và vùng nông thôn — nơi tỷ lệ lo âu cao nhưng sự tiếp cận dịch vụ thấp nhất.

5. Tiến độ dự kiến

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động chính
Chuẩn bị	Tháng 1–6 năm 1	Xin phê duyệt đạo đức, đào tạo nhóm, dịch và thử nghiệm công cụ
GĐ1: Cắt ngang	Tháng 7–12 năm 1	Khảo sát 6.000 HS tại 30 trường, 6 tỉnh
Phân tích GĐ1	Tháng 1–3 năm 2	Phân tích dữ liệu, thiết kế can thiệp
GĐ2: RCT	Tháng 4 năm 2 – tháng 3 năm 3	Can thiệp liệu pháp hành vi nhận thức + theo dõi 12 tháng
GĐ3: Định tính	Tháng 10 năm 2 – tháng 6 năm 3	Phỏng vấn sâu 70 người tham gia
Tổng hợp	Tháng 7–12 năm 3	Phân tích tích hợp, viết báo cáo, công bố

6. Tài liệu tham khảo

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Sage.

Daly, M. (2022). Prevalence of depression among adolescents in the U.S. from 2009 to 2019. Journal of Adolescent Health, 70(3), 496–499.

Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs. Health Services Research, 48(6pt2), 2134–2156.

GBD 2021 ASEAN Mental Disorders Collaborators. (2025). The epidemiology and burden of ten mental disorders in countries of the ASEAN, 1990–2021. The Lancet Public Health, 10, e480.

Hoàng Trung Học & Nguyễn Thùy Dung. (2025). Levels of Stress, Anxiety, and Depression in Adolescents during and after the COVID-19 Pandemic in Vietnam. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 28(1).

McLean, C. P., Asnaani, A., Litz, B. T., & Hofmann, S. G. (2011). Gender differences in anxiety disorders. Journal of Psychiatric Research, 45(8), 1027–1035.

Ngô Anh Vinh, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Bích Vân, et al. (2024). Mental health among ethnic minority adolescents in Vietnam. Journal of Affective Disorders Reports, 17.

Nguyễn Ngọc Bảo Quyên và cộng sự. (2025). Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh THPT tại Hà Nội. Tạp chí Y học Cộng đồng, 66.

Panchal, U., et al. (2023). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health. European Child & Adolescent Psychiatry, 32, 1151–1177.

Phạm Thị Thu Hoa, et al. (2024). Anxiety symptoms and coping strategies among high school students in Vietnam after COVID-19. Frontiers in Public Health, 12, 1232856.

Vũ Mạnh Lợi, et al. (2022). Viet Nam Adolescent Mental Health Survey (V-NAMHS): Report on Main Findings. Hanoi: Institute of Sociology.

Yin, S. Z. D., Low, M. K., & Mishu, M. P. (2025). School-based interventions to prevent anxiety and depression in LMICs: A systematic review. PLoS One, 20(4), e0316825.

Tài liệu tạo ngày 27/03/2026. Viết theo thuật toán mô phỏng phong cách Công Thị Hằng v5.